

OBJECTIF N°51 : Maladies veineuses thrombo-emboliques

Dr Mejd Ben Messaoud

- 1) **Les signes cliniques pouvant être compatibles avec le diagnostic de thrombophlébite des membres inférieurs sont :**
 - A- Une grosse jambe douloureuse
 - B- Une fièvre à 39°C
 - C- Une douleur du mollet à la flexion du pied
 - D- Une crampe du mollet
 - E- Une plaie infectée du même pied
 - F- Raréfaction des poils
 - G- Une diminution de la sensibilité superficielle
 - H- L'abolition des pous
 - I- Une augmentation de la chaleur locale
- 2) **Concernant les phlébites des membres inférieurs :**
 - A- Un taux de D-Dimères > 500 µg/l permet de confirmer le diagnostic de phlébite des membres inférieurs
 - B- Une phlébite haute se complique toujours d'embolie pulmonaire
 - C- Le signe de Homans est spécifique
 - D- La phlégmatisa Caerulea Dolens réalise une ischémie aiguë du membre inférieur
 - E- La thrombose cave est souvent asymptomatique
- 3) **Une phlébite des membres inférieurs peut se compliquer de :**
 - A- Une ischémie de membre inférieur
 - B- Une embolie pulmonaire
 - C- Un ulcère variqueux
 - D- Une endocardite infectieuse
 - E- Un infarctus de myocarde
- 4) **Les pathologies suivantes peuvent s'associer à une jambe œdématisée et douloureuse :**
 - A- Ischémie aiguë du membre inférieur
 - B- Phlébite du membre inférieur
 - C- Insuffisance cardiaque droite
 - D- Erysipèle de la jambe
 - E- Hématome du mollet
- 5) **Devant une forte suspicion de phlébite du membre inférieur, le premier examen à demander pour confirmer le diagnostic est :**
 - A- Angioscanner des membres inférieurs
 - B- Echographie doppler veineux des membres inférieurs
 - C- D-Dimères
 - D- Antithrombine III
 - E- Radiographie de la jambe
- 6) **Concernant le traitement curatif de la thrombose veineuse profonde :**
 - A- La contention élastique est à prescrire 12 heures/j dès le premier jour
 - B- L'anticoagulation orale doit être débutée le plus tôt possible
 - C- L'anticoagulation par voie parentérale fait appel préférentiellement à l'héparine non fractionnée
 - D- L'anticoagulation par l'Enoxaparine se fait par la dose 1000 UI/10 Kg une fois par jour
 - E- La durée de l'anticoagulation dépend de l'âge du patient
- 7) **Au cours de la thrombose veineuse profonde, l'anticoagulation au long cours :**
 - A- Doit être prolongée tant qu'un processus néoplasique est non encore guéri
 - B- Fait appel aux HBPM ou AOD en cas de cancer concomitant
 - C- Est de durée minimale de 3 mois
 - D- Peut être arrêtée immédiatement après disparition du facteur favorisant
 - E- Fait appel préférentiellement aux HBPM

8) Devant une TVP chez une jeune de 20 ans, vous suspectez en premier lieu :

- A- Thrombophilie
- B- Cancer
- C- Lupus
- D- Behçet
- E- Cardiomyopathie dilatée

9) En cas de phlegmatia coerulea dolens:

- A- Le tableau est celui d'ischémie aigüe du membre
- B- Il existe une cyanose du membre
- C- Le membre inférieur est peu douloureux
- D- Le membre inférieur est chaud
- E- L'œdème est souvent important
- F- Le pouls est présent
- G- Il y a une cyanose

10) Le dosage des D-Dimères est peu spécifique :

- A- Chez la femme enceinte
- B- Lorsque la probabilité clinique de la TVP est faible
- C- Chez les patients d'âge > 80 ans
- D- En post opératoire immédiat
- E- En cas de cancer évolutif

11) En cas de survenue de TVP, quels sont les éléments évocateurs de cause néoplasique ?

- A- Localisation atypique
- B- Récidive sous traitement anticoagulant
- C- Membre très inflammatoire
- D- Thrombose veineuse superficielle récidivante
- E- Atteinte bilatérale des membres inférieurs
- F- L'âge jeune

12) L'inhibiteur de coagulation le plus puissant est :

- A- La protéine S
- B- L'antithrombine
- C- La protéine C
- D- Le facteur VIII
- E- Le facteur V de Leiden

13) Une thrombophilie est à rechercher devant :

- A- TVS survenant avant 65 ans
- B- TVP avec facteur déclenchant
- C- TVP chez une femme de 30 ans
- D- TVP spontanée à 60 ans avec ATCD familiaux de TVP
- E- TVP proximale chez un sujet de 75 ans suite à un alitement

14) Le bilan de thrombophilie constitutionnelle comporte systématiquement le dosage de :

- A- AT III, Protéines C et S
- B- Anticardiolipines
- C- ANTI-β2GPI
- D- Mutation G20210 du gène de la prothrombine
- E- Résistance à la protéine C activée

15) Le marqueur biologique du SAPL le plus prédictif du risque thrombotique est :

- A- Anticorps anti- β2GPI type IgG
- B- Présence d'anticorps circulant type Lupique
- C- Anticorps anticardiolipine type IgG
- D- TP
- E- Plaquettes

16) La résistance à la protéine C activée :

- A- Est la thrombophilie constitutionnelle la plus fréquente
- B- Se transmet selon le mode autosomique récessif
- C- Est associée à un risque de thrombose plus élevé en cas de prescription d'oestroprogestatifs
- D- Est due à la mutation du facteur V de Leiden
- E- Est suspectée en cas de TVP inexplicée du sujet jeune

17) La principale étiologie du syndrome de Budd-Chiari est :

- A- Hémoglobinurie paroxystique nocturne
- B- Syndrome myélo-prolifératif
- C- Maladie de Behçet
- D- Maladie de Buerger
- E- Le SAPL

18) Une résistance à l'héparine évoque le diagnostic de :

- A- Déficit en protéine S
- B- Déficit en protéine C
- C- Déficit en antithrombine
- D- Mutation du facteur V de Leiden
- E- Une maladie de Behçet

19) Concernant les phlébites du membre supérieur :

- A- Elles sont plus emboligènes que celles des membres inférieurs
- B- Relèvent uniquement d'un traitement anti-inflammatoire
- C- La durée du traitement anticoagulant est de 6 mois au minimum
- D- Peuvent être en rapport avec une compression veineuse au niveau du défilé thoraco-brachial
- E- Peuvent être déclenchées par un effort physique
- F- Sont plus fréquentes que les phlébites des membres inférieurs

20) La survenue inopinée ambulatoire d'une phlébite doit faire évoquer :

- A- Un cancer digestif
- B- Une contraception orale
- C- Une hernie hiatale
- D- Un déficit en antithrombine III
- E- Une polyglobulie
- F- Un lupus
- G- Une maladie de Behçet
- H- Un SAPL
- I- Une hyperthyroïdie
- J- Une sclérodémie
- K- Un syndrome sec

21) La durée du traitement anticoagulant est de:

- A- 3 semaines à 3 mois en cas de phlébite distale non compliquée
- B- 3 à 6 mois en cas de phlébite distale compliquée d'embolie pulmonaire
- C- 3 à 6 mois en cas de phlébite proximale compliquée d'embolie pulmonaire
- D- 1 mois en cas de thrombose veineuse superficielle
- E- 6 mois en cas de thrombose veineuse avec une néoplasie active

22) Dans le syndrome de Cockett :

- A- Il y a une compression de la veine iliaque gauche par l'artère iliaque droite
- B- Il y a une compression de la veine iliaque droite par l'artère iliaque gauche
- C- Il est favorisé par la grossesse
- D- Donne souvent une TVP proximale gauche
- E- La phlébographie confirme le diagnostic et peut montrer une circulation collatérale

23) Sont des causes iatrogènes de TVP :

- A- Contraception orale
- B- Traitement par HNF
- C- Traitement par HBPM
- D- Mise d'un cathétérisme central
- E- Une coronarographie

24) L'échographie doppler veineux des MI indiquée devant une suspicion de TVP :

- A- Fait le diagnostic dans la majorité des cas
- B- Peut servir pour des contrôles ultérieurs
- C- Est un examen coûteux
- D- Est d'interprétation difficile
- E- N'est pas spécifique

25) Le signe échographique le plus spécifique de la phlébite des membres inférieurs est :

- A- Distension veineuse
- B- Collapsus veineux
- C- Incompressibilité de la veine
- D- Diminution du flux veineux
- E- Absence d'une veine

26) Les D-Dimères :

- A- Sont des produits de dégradation de la prothrombine
- B- Éliminent le diagnostic d'embolie pulmonaire si elles sont négatives
- C- Sont dosées par la technique ELISA
- D- Confirment le diagnostic de phlébite si elles sont positives
- E- Leur valeur seuil de positivité est de 500 µg/l ou 10 fois l'âge si âge avancé.

27) Sont des causes d'élévation des D-Dimères :

- A- Une insuffisance rénale
- B- Une insuffisance cardiaque
- C- L'âge avancé
- D- Une grossesse
- E- Une insuffisance surrénalienne
- F- Une insuffisance hépatique

28) La prévention de la TVP en postopératoire d'une chirurgie abdominale repose sur :

- A- Le lever précoce
- B- L'aspirine à dose antiagrégante
- C- Les HBPM à dose curative
- D- Les bas de contention
- E- Les AVK
- F- Les AOD à dose curative

29) L'embolie pulmonaire :

- A- Peut être asymptomatique
- B- Peut conduire à une insuffisance respiratoire chronique
- C- Peut révéler une thrombophlébite profonde inapparente
- D- Doit faire rechercher une extension cave à une thrombophlébite fémorale commune
- E- Peut compliquer une phlébite distale
- F- Est une pathologie rare
- G- Son diagnostic est facile

30) Parmi les signes électrocardiographiques suivants lesquels peuvent être rattachés à une embolie pulmonaire :

- A- Un aspect S en V1 et Q en V3
- B- Un bloc de branche droit
- C- Un axe droit
- D- Une Tachycardie
- E- Un bloc de branche gauche complet
- F- Un BAV
- G- Un microvoltage

31) Les signes hémodynamiques retrouvés en cas d'embolie pulmonaire à risque élevé sont :

- A- Élévation de la pression systolique dans le ventricule droit
- B- Élévation de la pression systolique dans le tronc de l'artère pulmonaire
- C- Élévation de la pression capillaire pulmonaire
- D- Baisse de la précharge du ventricule droit
- E- Diminution du débit cardiaque
- F- Diminution de la précharge du VG

32) Parmi les scores diagnostiques suivants lesquels sont utilisés en cas d'embolie pulmonaire :

- A- Le score TIMI
- B- Le score de Duke
- C- Le score de Wells
- D- Le score de Genève
- E- L'Euroscore
- F- Le score GRACE

33) Devant une dyspnée aiguë, les éléments en faveur d'embolie pulmonaire sont :

- A- Une radiographie de thorax normale
- B- Une tachycardie sinusale à l'ECG
- C- Un bloc de branche droit + axe droit à l'ECG
- D- Un effet shunt à la GDS
- E- Une douleur angineuse

34) Une embolie pulmonaire à risque élevé est définie par la présence de :

- A- Dyspnée
- B- Hypotension artérielle
- C- Tachycardie
- D- Syncope
- E- Arrêt cardiaque
- F- Signes périphériques de choc
- G- Effet shunt à la GDS

35) Devant une embolie pulmonaire à risque élevé chez un patient instable sur le plan hémodynamique, quel examen peut indiquer la thrombose :

- A- Le dosage des BNP
- B- Le dosage des D-Dimères
- C- L'échographie cardiaque transthoracique
- D- L'échographie cardiaque transoesophagienne
- E- Le dosage des troponines
- F- La radiographie de thorax

36) Le traitement anticoagulant indiqué devant une embolie pulmonaire :

- A- Doit être instauré d'emblée en cas de forte suspicion du diagnostic
- B- Se base sur les AVK pour le traitement au long cours
- C- Est prescrit pendant au moins 3 mois en cas de premier épisode d'embolie pulmonaire avec facteur réversible
- D- Doit être maintenu à vie en cas de récurrence
- E- Doit être maintenu à vie en cas de cancer guéri

37) L'embolie pulmonaire :

- A- Est une affection bénigne
- B- Est due à une obstruction totale de l'artère pulmonaire
- C- Est souvent méconnue est de diagnostic difficile
- D- Se caractérise par un polymorphisme clinique
- E- Est souvent localisée au niveau de l'artère pulmonaire gauche que droite

38) Au cours d'une embolie pulmonaire, la douleur :

- A- Est généralement brutale en coup de poignard
- B- Est souvent associée à une dyspnée
- C- Est soulagée par les dérivés nitrés
- D- Est soulagée par la position penchée en avant
- E- Est de siège rétrosternal

39) Parmi ces examens, quel est celui dont la normalité permet d'éliminer de façon certaine le diagnostic d'embolie pulmonaire quel que soit son niveau de probabilité ?

- A- Radiographie de thorax
- B- Scintigraphie de ventilation-perfusion
- C- EFR
- D- Angioscanner thoracique
- E- Échographie cardiaque

40) Les signes radiologiques suivants évoquent le diagnostic d'embolie pulmonaire :

- A- Opacité arrondie basale rétractile
- B- Atélectasies en bandes
- C- Ascension du diaphragme
- D- Épanchement pleural
- E- Poumon clair unilatéral
- F- Élargissement des espaces intercostaux

41) En cas d'embolie pulmonaire à risque élevé :

- A- Les HBPM doivent être prescrits sans délai
- B- L'oxygène doit être administré
- C- La dobutamine peut être utilisée en cas de bas débit cardiaque
- D- L'embolectomie chirurgicale ou percutanée est le traitement de première intention
- E- L'embolectomie chirurgicale ou percutanée est une alternative thérapeutique en cas d'échec ou de contre-indication absolue à la thrombolyse
- F- La thrombolyse est le traitement de première intention et certaines de ses contre-indications doivent être considérées comme relatives dans ce contexte
- G- Un remplissage vasculaire prudent (500 cc) est recommandé

42) La surveillance du traitement par HNF fait recours à :

- A- TCK
- B- TP
- C- Activité anti Xa
- D- Plaquettes
- E- NFS
- F- Fibrinogène
- G- D-Dimères
- H- Fonction rénale

43) Le bilan pré-thérapeutique avant la prescription du traitement anticoagulant doit comporter :

- A- TP-TCK
- B- Activité anti Xa
- C- NFS
- D- Créatinine
- E- Groupe sanguin

44) Les complications précoces liées à l'EP sont :

- A- Un EDC
- B- Une détresse respiratoire aigue
- C- Un IDM
- D- Un AVC ischémique
- E- Un infarctus pulmonaire
- F- Un CPC post-embolique

45) Les médicaments suivants potentialisent l'action des AVK :

- A- Chloramphénicol
- B- Phénobarbital
- C- AINS
- D- Cimétidine
- E- Rifampicine
- F- Dihydan

46) Quels sont les médicaments contre-indiqués au moment du diagnostic d'une embolie pulmonaire à haut risque ?

- A- La thrombolyse
- B- L'héparine non fractionnée
- C- Les HBPM
- D- Les AVK
- E- Le remplissage
- F- La dobutamine

47) Concernant les anticoagulants directs oraux :

- A- Ils inhibent de façon spécifique et directe les facteurs de coagulation activés
- B- Ils nécessitent une surveillance biologique
- C- Leur délai d'action est de 24 heures
- D- La warfarine appartient à cette classe d'anticoagulants
- E- Ils nécessitent un chevauchement avec HNF ou HBPM durant les premières 48 heures
- F- Ils peuvent être indiqués en cas de thrombose veineuse paranéoplasique

48) La prescription des HBPM au cours d'une phlébite doit être évitée dans les situations suivantes ?

- A- Une grossesse
- B- Une néoplasie
- C- Une insuffisance rénale sévère
- D- Un poids inférieur à 40 Kg
- E- Un poids supérieur à 100 Kg

49) La thrombopénie induite à l'héparine :

- A- Survient plus fréquemment avec les HBPM
- B- Impose l'arrêt de l'héparine
- C- Peut se compliquer de thrombose veineuse
- D- Peut se compliquer d'une hémorragie
- E- Est dose dépendante
- F- Est plus fréquente chez les sujets âgés

50) L'embolie pulmonaire est responsable au niveau du territoire embolisé :

- A- D'un effet shunt
- B- D'un effet espace mort
- C- D'un infarctus pulmonaire
- D- D'une diminution du rapport Ventilation / perfusion
- E- D'une bronchoconstriction

51) L'effet espace mort :

- A- Est secondaire à une augmentation du volume sanguin des capillaires pulmonaires
- B- Est la première conséquence respiratoire au cours d'une embolie pulmonaire
- C- Correspond à un territoire ventilé non perfusé
- D- Se manifeste au niveau du territoire non embolisé
- E- Représente une zone qui ne participe pas aux échanges gazeux

52) L'effet shunt :

- A- Est défini par une augmentation du rapport ventilation / perfusion
- B- Caractérise le territoire non embolisé de l'embolie pulmonaire
- C- Est responsable d'une hypoxie
- D- Est secondaire à une redistribution sanguine vers les territoires non embolisés
- E- Est le premier effet qui apparaît au cours d'une embolie pulmonaire

53) Concernant l'embolie pulmonaire :

- A- Les D-Dimères négatifs éliminent le diagnostic
- B- Les Dimères sont indiqués de première intention en cas d'embolie pulmonaire à forte probabilité.
- C- La présence de signes de cœur pulmonaire aigu à l'ETT est une indication à la thrombolyse en cas de suspicion d'EP à haut risque avec non disponibilité d'angioscanner
- D- La présence d'une tachycardie et une dyspnée inexpliquées avec une radiographie de thorax normale est fortement évocatrice du diagnostic
- E- Sa démarche diagnostique dépend de scores de probabilité

54) Le traitement au long cours d'une embolie pulmonaire suite à une immobilisation plâtrée peut comporter :

- A- Les HBPM
- B- Le dabigatran
- C- La warfarine
- D- L'acénocoumarol
- E- Le rivaroxaban
- F- L'aspirine

55) Une thrombophilie constitutionnelle peut être secondaire à :

- A- Une mutation du facteur V de Leiden
- B- Un déficit en protéine C et S
- C- Un syndrome des anti phospholipides
- D- Un déficit en antithrombine
- E- Un syndrome myéloprolifératif
- F- Une mutation du gène 20210 de la prothrombine

56) Les facteurs de coagulation impliqués dans la voie intrinsèque sont :

- A- VIII
- B- IX
- C- X
- D- XI
- E- XII

57) Le(s) facteur(s) de coagulation impliqué(s) dans la voie extrinsèque est(sont) :

- A- VII
- B- VIII
- C- IX
- D- X
- E- XI

58) Le complexe prothrombinase associe les facteurs :

- A- Va
- B- VIIa
- C- VIIIa
- D- IXa
- E- Xa

59) Les facteurs vitamine K dépendants sont :

- A- II
- B- V
- C- VII
- D- IX
- E- X

60) L'antithrombine :

- A- Est le principal inhibiteur de la coagulation
- B- Est vitamine K dépendante
- C- Est cofacteur de l'héparine
- D- Agit essentiellement sur la fibrine et le facteur Xa
- E- Est une enzyme synthétisée par le foie

61) Les signes suivants témoignent de la gravité immédiate d'une embolie pulmonaire :

- A- Cyanose persistante sous oxygénothérapie
- B- Collapsus cardio-vasculaire
- C- Hémoptysie
- D- Tachycardie > 120
- E- Intensité de la douleur thoracique

62) En cas d'embolie pulmonaire à risque élevé, la thrombolyse peut être indiquée devant les signes échographiques suivants :

- A- Une dilatation du ventricule droit
- B- Un septum inter-ventriculaire paradoxal
- C- Une hypertension artérielle pulmonaire
- D- Une dilatation du ventricule gauche
- E- Une veine cave inférieure fine et collabée

- 63) En cas d'une thrombose veineuse du membre inférieur, une thrombophilie constitutionnelle est suspectée devant :**
- A- Le caractère récidivant de la thrombose
 - B- La survenue de la thrombose à l'âge de 35 ans
 - C- La survenue d'une nécrose cutanée sous anti-vitamine K
 - D- Le siège de la thrombose au niveau du membre supérieur
 - E- La survenue de la thrombose dans un contexte post-opératoire
- 64) En cas de thrombose veineuse superficielle, une anticoagulation curative pendant 3 mois est indiquée en cas de :**
- A- TVS < 5 cm avec une distance < 3 cm par rapport à la jonction avec le système veineux profond
 - B- TVS < 5 cm avec une distance $\geq$ 3 cm par rapport à la jonction avec le système veineux profond
 - C- TVS $\geq$ 5 cm avec une distance < 3 cm par rapport à la jonction avec le système veineux profond
 - D- TVS $\geq$ 5 cm avec une distance $\geq$ 3 cm par rapport à la jonction avec le système veineux profond
 - E- TVS < 5 cm avec une distance $\geq$ 10 cm par rapport à la jonction avec le système veineux profond
- 65) En cas de thrombose veineuse profonde, une anticoagulation prolongée est indiquée en cas de :**
- A- Grossesse
 - B- Cancer non guéri
 - C- Thrombophilie
 - D- Thromboses récidivantes
 - E- Thrombose du membre supérieur

Cas clinique n°1 :

Un homme de 25 ans, footballeur, ayant un poids de 80 Kg, sans antécédents médicaux connus est hospitalisé pour une forte suspicion de thrombose veineuse profonde du membre inférieur gauche évoluant depuis quelques heures :

1- Quel examen para clinique demandez-vous de première intention pour confirmer le diagnostic de cette thrombose veineuse ?

- A- Écho-doppler veineux des MI
- B- Angioscanner des membres inférieurs
- C- Phlébographie des membres inférieurs
- D- Dosage des D-Dimères
- E- Une radiographie de la jambe gauche

2- Quel serait votre attitude thérapeutique de première intention une fois la thrombose veineuse est confirmée ?

- A- AOD seul
- B- HBPM seule
- C- HBPM + AVK
- D- HNF + AVK
- E- AVK seul

Le lendemain, le patient est devenu anxieux, polypnéique avec auscultation pulmonaire normale, tachycarde à 110 bpm, fébrile à 38°2, sa TA est à 120/80, son hypochondre droit est sensible avec reflux hépato-jugulaire.

L'examen note une jambe et une cuisse œdématisées et chaudes avec des pouls conservés.

L'ECG montre une tachycardie sinusale à 120 bpm avec onde T négative en V1-V2-V3.

La radiographie du thorax est normale.

3- Quel est votre diagnostic?

- A- Embolie pulmonaire à risque élevé
- B- Embolie pulmonaire à risque intermédiaire
- C- Embolie pulmonaire compliquée d'un SCA
- D- Une phlébite bleue compliquée d'embolie pulmonaire
- E- Une thrombose iléo-cave

4- Quel(s) examen(s) complémentaire(s) pouvez-vous demander pour confirmer ce diagnostic ?

- A- Angioscanner pulmonaire
- B- Angiographie pulmonaire
- C- Scintigraphie pulmonaire
- D- Dosage des D-Dimères
- E- Échographie cardiaque

5- Les étiologies suivantes peuvent être à l'origine de cette thrombose veineuse chez ce patient :

- A) Une néoplasie
- B) Un déficit en antithrombine
- C) Un déficit en protéine C
- D) Une maladie de Takayasu
- E) Une maladie de Behçet

Cas clinique n°2 :

Un homme de 35 ans est hospitalisé dans un tableau de troubles de la conscience, d'une pression artérielle basse à 80/50 mmHg, d'une froideur et marbrures des extrémités, d'un pouls rapide et filant, d'une hépatomégalie avec turgescence franche des veines jugulaires.

Un plâtre lui a été posé 2 semaines auparavant pour fracture de jambe et l'interrogatoire de l'entourage ne révèle pas d'antécédents médicaux.

1- Quel diagnostic évoquez-vous en premier ?

- A- Une embolie pulmonaire à risque élevé
- B- Un IDM inférieur étendu au VD
- C- Une tamponnade
- D- Un pneumothorax bilatéral suffocant
- E- Une dissection de l'aorte

2- Quel examen demandez-vous en premier pour guider votre attitude thérapeutique ?

- A- Une échographie cardiaque trans-thoracique
- B- Une échographie cardiaque trans-oesophagienne
- C- Un angioscanner aortique
- D- Une coronarographie
- E- Une IRM thoracique

3- Une fois votre diagnostic est confirmé, votre attitude thérapeutique en urgence comporte :

- A- Un remplissage prudent
- B- Une thrombolyse
- C- La prescription d'HBPM
- D- Une angioplastie primaire
- E- Un drainage péricardique
- F- Un drainage thoracique
- G- Une chirurgie de l'aorte

Cas clinique n°3 :

Patiente âgée de 40 ans, hypertendue, ayant un poids de 60 Kg, se présente pour un tableau de thrombose de la veine fémorale superficielle du membre inférieur gauche après un voyage en voiture de 8 heures.

Elle est sous contraception orale. La patiente signale que sa mère a fait deux phlébites du post-partum.

- 1- Quels sont les facteurs de risque de la TVP chez cette patiente ?**
 - A- Le voyage de 8 heures
 - B- La contraception orale
 - C- Les antécédents de phlébite chez la mère
 - D- Le sexe féminin
 - E- L'âge jeune
 - F- L'HTA

- 2- Vous avez décidé de pratiquer un bilan de thrombophilie. Sur quels arguments avez – vous pris cette décision ?**
 - A- Le voyage de 8 heures
 - B- La contraception orale
 - C- Les antécédents de phlébite chez la mère
 - D- Le sexe féminin
 - E- L'âge jeune
 - F- L'HTA

- 3- Vous avez décidé de commencer le traitement par des HBPM en association avec un AVK.**

Quel(s) est (sont) l' (les) avantage(s) de la prescription des HBPM par rapport à celle de l'Héparine calcique ?

 - A- L'utilisation de la voie sous cutanée
 - B- Un risque moindre de TIH
 - C- Un risque moindre de survenue d'évènements hémorragiques
 - D- La possibilité de prescription en cas d'insuffisance rénale sévère
 - E- L'absence d'indication à une surveillance du taux des plaquettes

- 4- Quels sont les paramètres biologiques à surveiller après la prescription des HBPM ?**
 - A- NFS
 - B- Fonction rénale
 - C- TCK
 - D- TP
 - E- Activité anti Xa

- 5- Quels sont les mesures préventives à instaurer chez cette patiente :**
 - A- La contention élastique des membres inférieurs dès l'équilibration de l'INR
 - B- L'arrêt des oestroprogestatifs
 - C- L'éviction ou la prise de mesures préventives nécessaires en cas de voyage de longue durée
 - D- La prescription d'aspirine en plus du traitement anticoagulant
 - E- Le repos strict au lit jusqu'à l'équilibration de l'INR